

X ライノウイルスなどのウイルスが全体の約 90% を占め、その他に百日咳菌やマイコプラズマも原因となる（慢性呼吸器疾患がある患者では、肺炎球菌などによる二次性の細菌感染を合併することもある）。

O

O

X 乳児において無呼吸発作を引き起こす。

X 百日咳菌の培養には特殊培地が必要であり、培養陽性率も低い
ため、IgM/IgA 抗体や PT-IgG 抗体、Loop-mediated isothermal
amplification (LAMP) 法・PCR 法で診断に至ることが多い。

X マクロライド系抗菌薬を用いる。

X 除菌による周囲への感染予防の目的として抗菌薬投与が推奨される。

O 近年は高齢者における RS ウイルスやヒトメタニューモウイルスによる細気
管支炎の報告があるが、頻度としては圧倒的に小児が多い。

X 先天性心疾患や免疫不全など、一部の基礎疾患を有する児に対してのみ
適応となる。

X マイコプラズマや肺炎クラミジア（クラミドフィラ）など、特定の微生物が
原因として疑われる場合に抗菌薬を使用する。

X 十分なエビデンスはなく、症例毎に検討する。

X 2017 年の時点では 5 位である。

X 入院後 48 時間後以降に発症した肺炎と定義される。

1